

# एनेस्थीसिया में मूत्रवाहिनी जाँच

रोगी जानकारी • मूत्रवाहिनी की संकुचन की मैपिंग — मरम्मत से पहले

WARWIKI

यह मूत्रवाहिनी (ureter) की विस्तृत जाँच है — वह नली जो गुर्दे से मूत्राशय तक पेशाब ले जाती है — जो एनेस्थीसिया में की जाती है। आपके सर्जन कुछ जाँचों को मिलाकर यह पता लगाते हैं कि संकुचन कहाँ है और कितना लंबा है, ताकि सही मरम्मत की योजना बन सके।

## इस जाँच के बारे में

मूत्रवाहिनी में संकुचन (stricture) को बाहर से नापना मुश्किल है, इसलिए सर्जन एनेस्थीसिया में सीधे देखते हैं। ज़रूरत के अनुसार जाँच में इनमें से **कोई भी संयोजन** शामिल हो सकता है:

- **Diagnostic ureteroscopy** — मूत्रवाहिनी में डाला गया पतला, लचीला camera।
- **Retrograde pyelogram** — मूत्राशय से ऊपर डाई इंजेक्ट कर X-ray से नली की छवि।
- **Antegrade pyelogram** — यदि गुर्दे में drainage tube है, तो डाई ऊपर से नीचे संकुचन के आर-पार डाली जाती है।
- **Cystoscopy / cystogram** — मूत्राशय के अंदर देखना और X-ray चित्र।

लक्ष्य है एक सटीक नक्शा — संकुचन की जगह, लंबाई और तंगी। उसी दौरे में stent या kidney tube लगाया या बदला जा सकता है।

## क्या यह सुरक्षित है?

हाँ। यह एक सामान्य, कम जोखिम वाली जाँच है। ज़्यादातर लोगों को बाद में थोड़ी देर के लिए पेशाब में खून, हल्की जलन या कमर में हल्का दर्द होता है। कभी-कभी UTI या मूत्रवाहिनी में जलन हो सकती है; मूत्रवाहिनी में चोट दुर्लभ है। एनेस्थीसिया आमतौर पर बहुत सुरक्षित होती है।

## शब्दों को समझें

### Ureter (मूत्रवाहिनी)

गुर्दे से मूत्राशय तक पेशाब ले जाने वाली नली।

### Stricture

नली का घाव से सँकरा हो जाना, जिससे पेशाब धीरे बहता है।

### Ureteroscopy

पतले, लचीले camera से मूत्रवाहिनी के अंदर देखना।

### Retrograde pyelogram

मूत्राशय से डाई ऊपर डालकर X-ray लेना।

### Antegrade pyelogram

गुर्दे की drainage tube से डाई नीचे डालकर X-ray लेना।

### Nephrostomy tube

पीठ के रास्ते गुर्दे से पेशाब निकालने वाली tube।

### Contrast dye

X-ray पर सफ़ेद दिखने वाला तरल, जो नली की रूपरेखा दिखाता है।

### Stent

मूत्रवाहिनी को खुला रखने वाली नरम अंदरूनी tube।

**क्या इसमें दर्द होगा?** जाँच के दौरान आप एनेस्थीसिया में सोए रहते हैं, इसलिए कुछ महसूस नहीं होता। बाद में 1-2 दिन हल्की जलन, कमर में हल्का दर्द या पेशाब में हल्का खून आ सकता है। यह छोटी प्रक्रिया है और आप आमतौर पर उसी दिन घर जा सकते हैं।

### तैयारी कैसे करें (जाँच से पहले)

- यह **एनेस्थीसिया** में होती है — सर्जरी के सभी निर्देश मानें (खाली पेट रहना और कौन-सी दवाएँ बंद करनी हैं, जिनमें blood thinner शामिल हैं)।
- **Urine test** से संक्रमण की जाँच होती है — संक्रमण हो तो पहले इलाज ज़रूरी है।
- कोई भी मौजूदा **kidney tube या stent** यथास्थान रहने दें और **घर जाने के लिए किसी को साथ लाएँ।**

### पहले से बता दें यदि आपको:

- **X-ray contrast dye या iodine** से कभी एलर्जी हुई हो
- आप **blood thinner** लेते हों, या UTI के लक्षण हों

### जाँच के दौरान क्या होता है

- 1 आप एनेस्थीसिया में सोए रहते हैं और antibiotics दिए जाते हैं।
- 2 Cystoscope मूत्राशय में डाला जाता है। मूत्रवाहिनी में ऊपर डाई इंजेक्ट कर X-ray लिए जाते हैं और/या camera से अंदर देखा जाता है।
- 3 यदि kidney tube है, तो ऊपर से डाई डालकर दोनों दिशाओं से संकुचन दिखाया जा सकता है।
- 4 निष्कर्षों का नक्शा बनाया जाता है और ज़रूरत हो तो stent या kidney tube लगाया या बदला जाता है।

### बाद में

- एनेस्थीसिया से ठीक होने के बाद आप आमतौर पर **उसी दिन घर** जाते हैं।
- 1-2 दिन **हल्की जलन, कमर का दर्द, या हल्का गुलाबी पेशाब** हो सकता है। अधिक पानी पीने से राहत मिलती है।
- Stent लगा हो तो पेशाब की तीव्र इच्छा या हल्की तकलीफ सामान्य है।
- सर्जन नक्शा देखकर मरम्मत की अगली योजना बताएँगे।

### यदि आपको ये हों तो अपनी चिकित्सा टीम को बुलाएँ:

- बुखार या ठंड लगना
- कमर या पेट में तेज़ या बढ़ता दर्द
- अधिक रक्तस्राव या पेशाब में खून के थक्के
- पेशाब करने में कठिनाई, या लगातार मतली/उल्टी

### याद रखने योग्य तीन बातें

1. यह जाँच एनेस्थीसिया में camera और X-ray डाई से मूत्रवाहिनी के संकुचन का नक्शा बनाती है, ताकि सर्जन सही मरम्मत की योजना बना सकें।
2. एनेस्थीसिया होने के कारण खाली पेट रहें, बताई दवाएँ बंद करें, पहले संक्रमण का इलाज कराएँ, kidney tube या stent यथास्थान रखें और साथ आने वाला कोई हो।
3. ज़्यादातर लोग उसी दिन घर जाते हैं। 1-2 दिन हल्की जलन, कमर दर्द या हल्का गुलाबी पेशाब सामान्य है — अधिक पानी पिएँ; बुखार, तेज़ दर्द या अधिक रक्तस्राव पर तुरंत बताएँ।